

Información Paciente

Nombre : Hernan Herrera Araya
Edad : 78a 2m 2d
Dirección : Juan Mackenna 795 El Tranque

Rut : 4.801.807-6
Fecha Nacto: 04/06/1944
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0118933
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 5770 9772

N° Epicrisis
318222

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalizacion

Fecha Ingreso : 06/08/2022 01:36

Días Estadía : 1

Unidad de Egreso : Emergencia Adulto

Fecha Egreso : 06/08/2022 14:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

tos con secrecion

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

RESUMEN DE TRASLADO

Contacto hijo: 878614478 Nestor

Antecedentes

AM: HTA, DM2IR, ACV Hemorrágico enero 2022, secuelado. Enfermedad coronaria conocida.

Cx: CRM

Alergias:-

Funcionalidad: Postrado secundario a acv, no se comunica, dependiente ABV, usuario sng

Historia actual

Familiar refiere cuadro iniciado hace una semana de tos con expectoración con mal manejo de secreciones, quejumbroso. niega fiebre, no refiere otros síntomas evidentes, paciente no comunica. Además refiere compromiso de conciencia cualitativo, sin nuevo déficit neurológico, sin fenómenos convulsivos, tampoco refiere trauma.

Ex físico ingreso

vigil, sin lenguaje, localiza dolor, no sigue ordenes simples
normocardico, hipertenso, eupneico, afebril.
pupilas isocoricas, hiporreactivas
pc no evaluables
yugulares planas
rr2tss
mp disminuido, crepitos y roncus bilaterales, ruidos de vas, sin uma
abd rha + bdi
eeii sin edema ni dolor dg insuf respiratoria aguda obs nac
hipoglicemia

Fecha Última Actualización: 06-08-2022 14:56:55

Página 2 de 3

lab so normal, elp 118/5/87, hb 12.4, gb 4.940, neut 57%, ran 2.800, pqt 257.000, tp 13.7, inr 1.16, ttpa 29.7, lactato 12.1, au 1.6, alb 3.5, amilasa 51, bt 0.27, fa 102, ggt 79, got 42, gpt 28, ca 8.8ckt 94, crea 0.45, bun 8.5, gluc 126, ldh 395, lipasa 13, pt 6.7, pcr 3.4

tac tx: Marcados cambios inflamatorios de vía aérea de mediano calibre con fenómenos de impactación mucosa y áreas de bronquiolititis en lóbulos inferiores. Considerar fenómenos aspirativos. Correlacionar con elementos clínicos y controlar. Cardiomegalia de predominio izquierdo. Ateromatosis aortocoronaria.

dg. hiponatremia 118
insuf resp aguda obs nac aspirativa
obs comp conciencia

Se hospitaliza por req de O2, para manejo de infección y corrección de medio interno.

Evolución 6/08/22

Paciente en RCG (similar a lo descrito al ingreso), pero tranquilo y estable. Con mala movilización de secreciones, se escuchan ruidos de VAS. Normocardico, normotenso, afebril, sat 95% con 2 lt por naricera. Sin apremio ventilatorio

Ex físico
Sopor profundo, localiza dolor
Bien perfundido, mucosas secas
RR2T, NAS MP (+) Ruidos transmitidos de VAS, roncus bilateral. Sin UMA
ABD BDI RHA_z+
EEII sin edema ni signos TVP

TAC cerebro sin sangrado ni tumor. Impresiona dilatación de sist ventricular, hidrocefalia?.

Lab: control ELP Na 120,

Plan:
1 HDN: Estable sin conflicto
2. Medio interno: Cursando con Hiponatremia con VEC disminuido. Control post 1er SF 3% 150 ml Na 118 --> 120. No corrigió conciencia por lo que indico el segundo hipertónico. Control ELP post solicitado luego suerode mantención para corregir 8 mEq / día.
3. Infeccioso/ Ventilatorio: En segundo día de terapia ATB primera línea, sin peak febril. Parámetros inflamatorios bajos, pero dado clínica sugerente + req de O2 mantengo terapia.
4. Neurológico: Compromiso de conciencia en estudio, impresiona origen toxico metabólico por hiponatremia severa. Tiene TAC de cerebro que no muestra sangrado ni evnto agudo.
Se postula para traslado a HSJM

INDICACIONES

1. Reposo absoluto
2. Regimen Diabético hiposodico por SNG
3. CSV Cada 6 hrs + HGT
4. KNT R
5. Aspiración secreciones
6. O2 para SAT > 92%
7. Ceftriaxona 2 gr EV al día
8. Fenitoína 100mg c 8 hrs x SNG
9. Quetiapina 25 mg cada noche x SNG
10. Carvedilol 3,125 cada 12 horas x SNG
11. Atorvastatina 40 mg cada noche
13. Omeprazol 20 mg al día VO
14. Berodual NBZ cada 8 hrs

Fecha Epicrisis : 06/08/2022 14:56

Página 2 de 3

Diagnóstico de Egreso

Compromiso de conciencia en estudio -

Condición de Egreso Otro

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Sergio Fuentes Sainz
Médico Tratante (Staff)